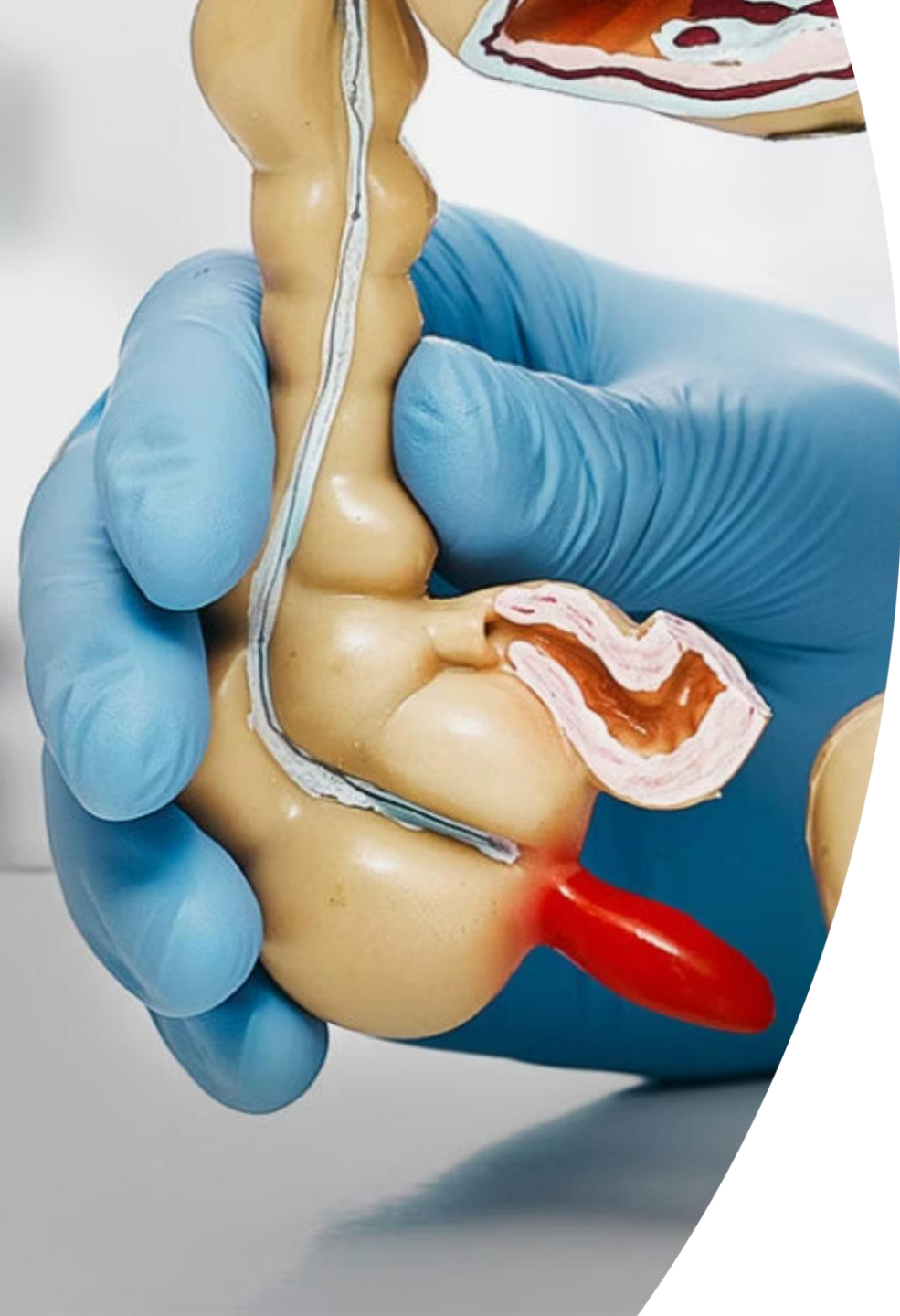




Évaluation du Cours de Résidanat : Sujet 4 Appendicite Aiguë

Présenté par le Pr. Aymen TRIGUI et le Pr. Ag. Sami FENDRI
Service de Chirurgie Générale

Date: 28/07/2025

QCM: Les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques



Les différentes situations de l'appendice sont au niveau:

- A. De la fosse Iliaque droite
- B. Sous hépatique fréquemment
- C. Iliaque gauche en cas de situs-inversus
- D. Pelvienne en cas de défaut de migration
- E. Lombaire droite en cas de défaut de rotation intestinale

QCM: Les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques



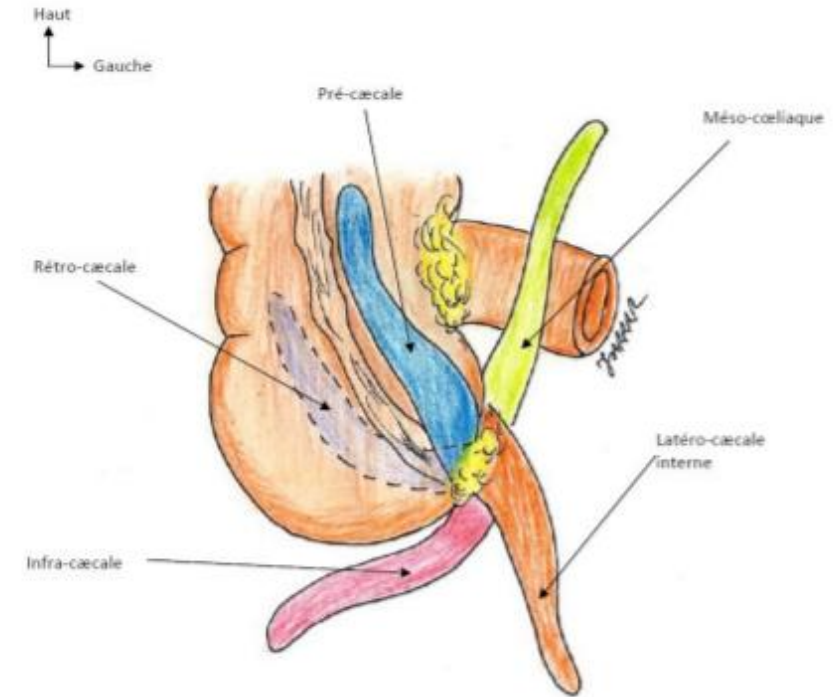
Les différentes situations de l'appendice sont au niveau:

- A. De la fosse Iliaque droite
- B. Sous hépatique fréquemment
- C. Iliaque gauche en cas de situs-inversus
- D. Pelvienne en cas de défaut de migration
- E. Lombaire droite en cas de défaut de rotation intestinale

QCM: Les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques

L'appendice:

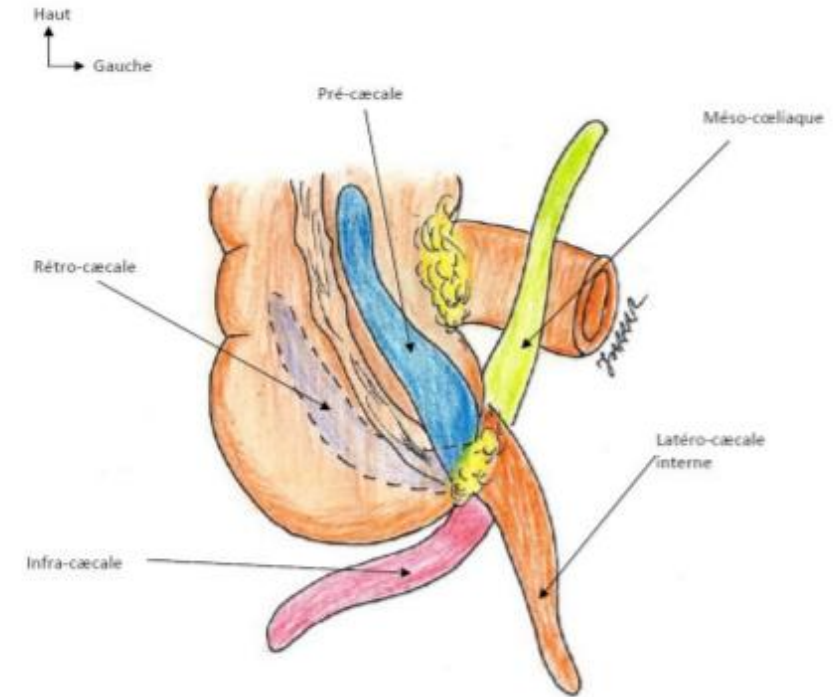
- A. Appartient au colon
- B. S'implante sur la face antérieure caecale
- C. Peut être latéro-caecale interne
- D. Peut être méso-coéliaque
- E. Présente une pointe fixe et une base mobile



QCM: Les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques

L'appendice:

- A. Appartient au colon
- B. S'implante sur la face antérieure caecale
- C. Peut être latéro-caecale interne
- D. Peut être méso-coeliaque
- E. Présente une pointe fixe et une base mobile



QCM: Les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques



Les rapports de l'appendice sont:

- A. La paroi abdominale en postérieur
- B. La paroi abdominale en externe
- C. L'intestin grêle en interne
- D. Le rein droit en antérieur
- E. L'uretère en antéro-latéral

QCM: Les variations anatomiques de l'appendice et ses rapports anatomiques



Les rapports de l'appendice sont:

- A. La paroi abdominale en postérieur
- B. La paroi abdominale en externe
- C. L'intestin grêle en interne
- D. Le rein droit en antérieur
- E. L'uretère en antéro-latéral

Modification



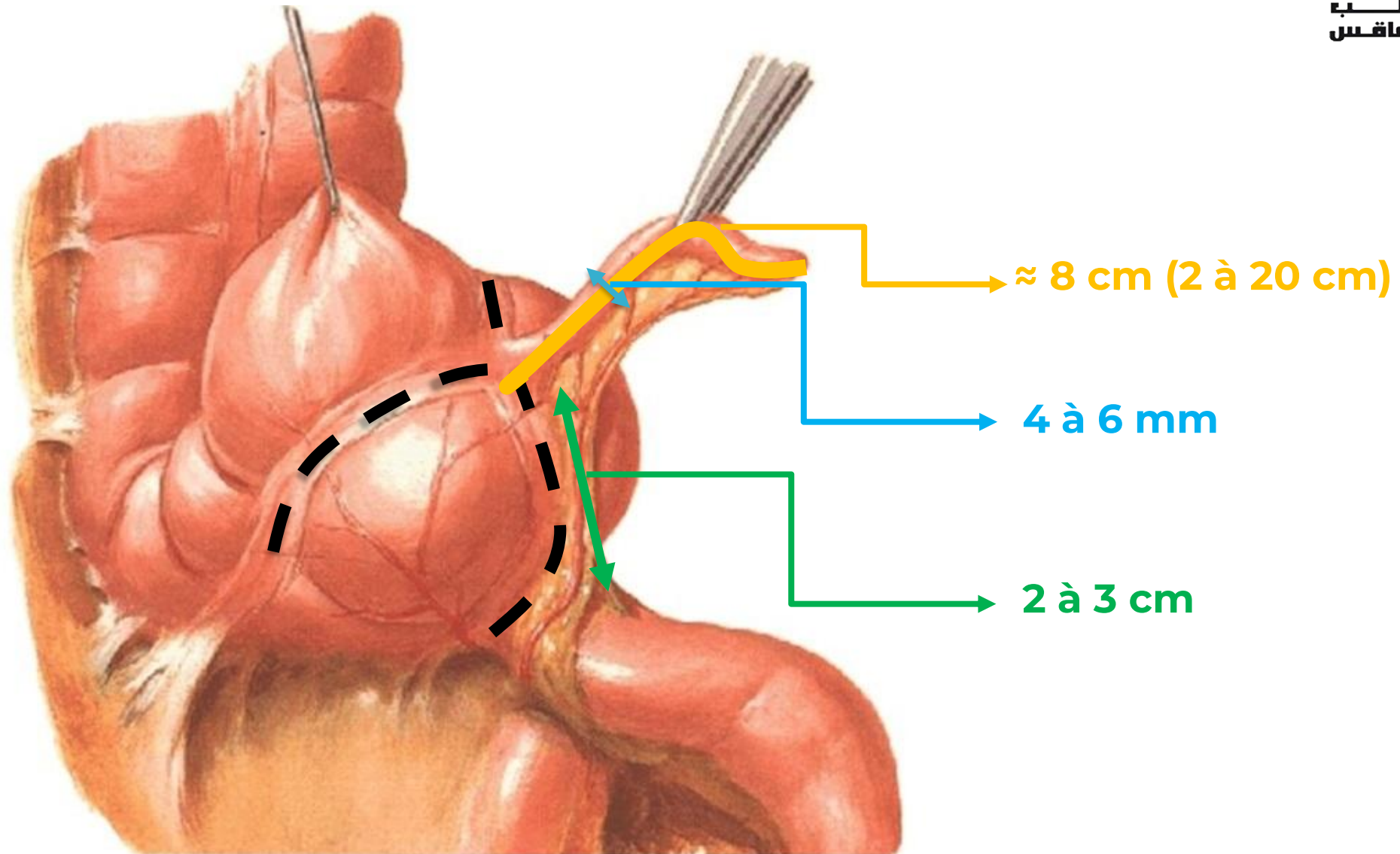
L'appendice vermiforme:

C'est un tube flexueux, implanté sur la face interne du cæcum, au point de convergence des trois tænias. C'est un organe propre à l'homme et aux singes anthropoïdes.

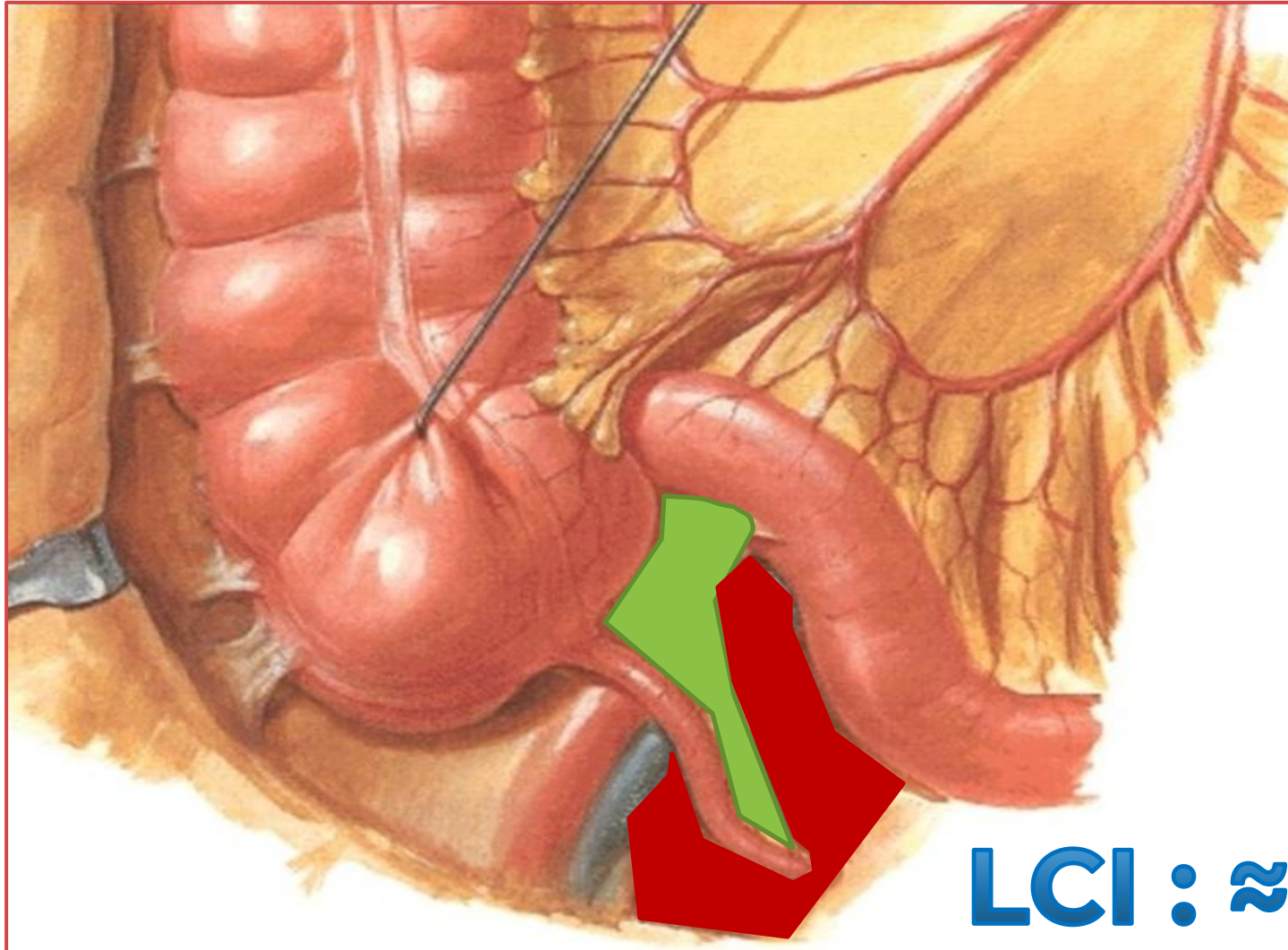
a. Dimensions :

- Longueur : moyenne de 7 à 8 cm (variable : 2 à 20 cm) ;
- Calibre : ~~4 à 8 mm~~ **4 à 6 mm**

Rappel anatomique



Rappel anatomique



LCI : $\approx$ 70 %

QCM: Mécanismes étiopathogéniques des appendicites aiguës



Le mécanisme étio-pathogénique de l'appendicite aiguë peut être :

- A. Une obstruction de la lumière par des selles liquides
- B. Une obstruction de la lumière par une hyperplasie du tissu lymphoïde
- C. Une sténose inflammatoire de l'appendice
- D. Une compression de l'appendice par une bride
- E. Une obstruction de la lumière appendiculaire par une tumeur

QCM: Mécanismes étiopathogéniques des appendicites aiguës



Le mécanisme étio-pathogénique de l'appendicite aiguë peut être :

- A. Une obstruction de la lumière par des selles liquides
- B. Une obstruction de la lumière par une hyperplasie du tissu lymphoïde
- C. Une sténose inflammatoire de l'appendice
- D. Une compression de l'appendice par une bride
- E. Une obstruction de la lumière appendiculaire par une tumeur

QCM: Mécanismes étiopathogéniques des appendicites aiguës



Une appendicite aiguë peut être secondaire à une:

- A. Obstruction luminale par un stercolithe
- B. Obstruction parasitaire
- C. Une sténose inflammatoire de la paroi appendiculaire
- D. Atteinte par voie lymphatique
- E. Atteinte par contiguïté

QCM: Mécanismes étiopathogéniques des appendicites aiguës



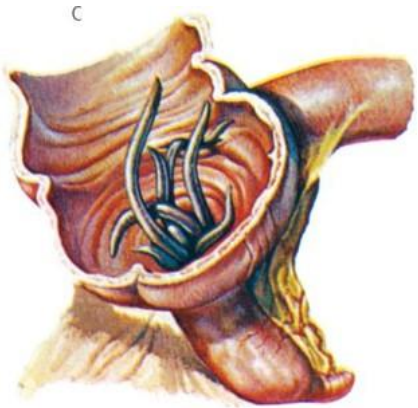
Une appendicite aiguë peut être secondaire à une:

- A. Obstruction luminale par un stercolithe
- B. Obstruction parasitaire
- C. Une sténose inflammatoire de la paroi appendiculaire
- D. Atteinte par voie lymphatique
- E. Atteinte par contiguïté

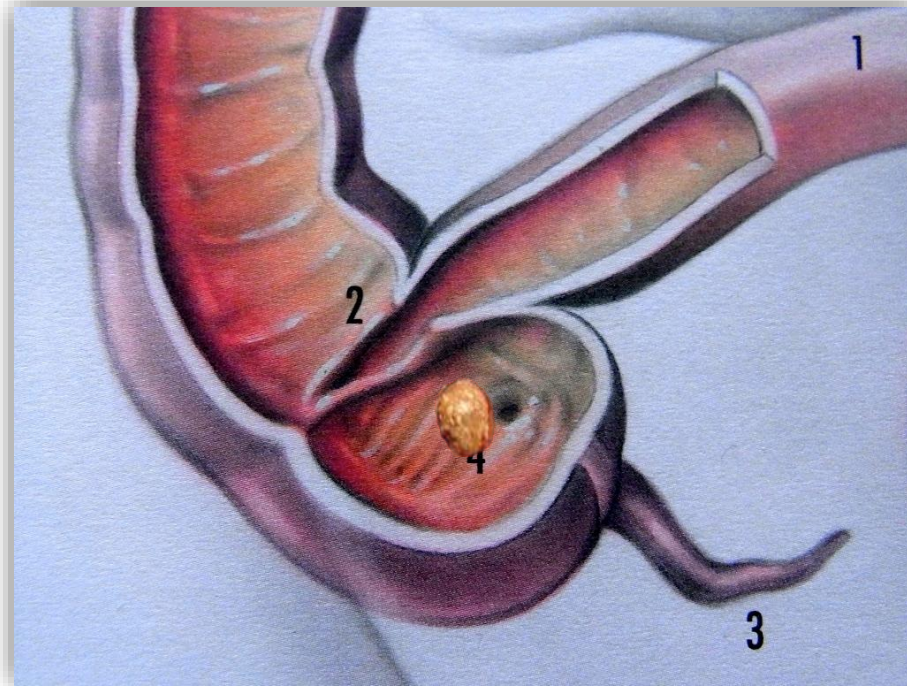
Physiopathologie

-> Mécanismes :

- Obstructive : ++++

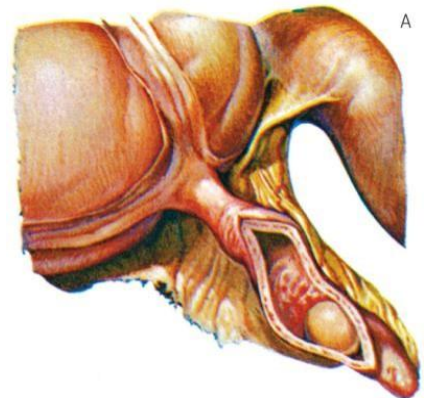


Ou Parasitaire



Stercolithe

+++



QCM: Mécanismes étiopathogéniques des appendicites aigues



Concernant l' étiopathogénie de l'appendicite aigue:

- A. La pullulation microbienne constitue la première étape
- B. L'obstruction de la lumière constitue la dernière étape
- C. Une augmentation de la pression intra luminale est présente
- D. La gangrène pariétale est secondaire à des thromboses vasculaires
- E. La pullulation microbienne est à l'origine d'une obstruction de la lumière

QCM: Mécanismes étiopathogéniques des appendicites aigues



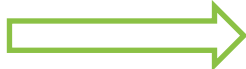
Concernant l' étiopathogénie de l'appendicite aigue:

- A. La pullulation microbienne constitue la première étape
- B. L'obstruction de la lumière constitue la dernière étape
- C. Une augmentation de la pression intra luminale est présente
- D. La gangrène pariétale est secondaire à des thromboses vasculaires
- E. La pullulation microbienne est à l'origine d'une obstruction de la lumière

Physiopathologie



-> Conséquence locorégional:

✓ Stase + Pression intra luminale  pullulation microbienne

 inflammation pariétale: **dl + fièvre**

✓ Pus intra-luminal

✓ Altération vascularisation pariétale  appendicite **gangréneuse**

✓ Perforation  **Abcès ou péritonite**

QCM: Aspects anatomopathologiques des appendicites aiguës

Au cours d'une appendicite catarrhale :

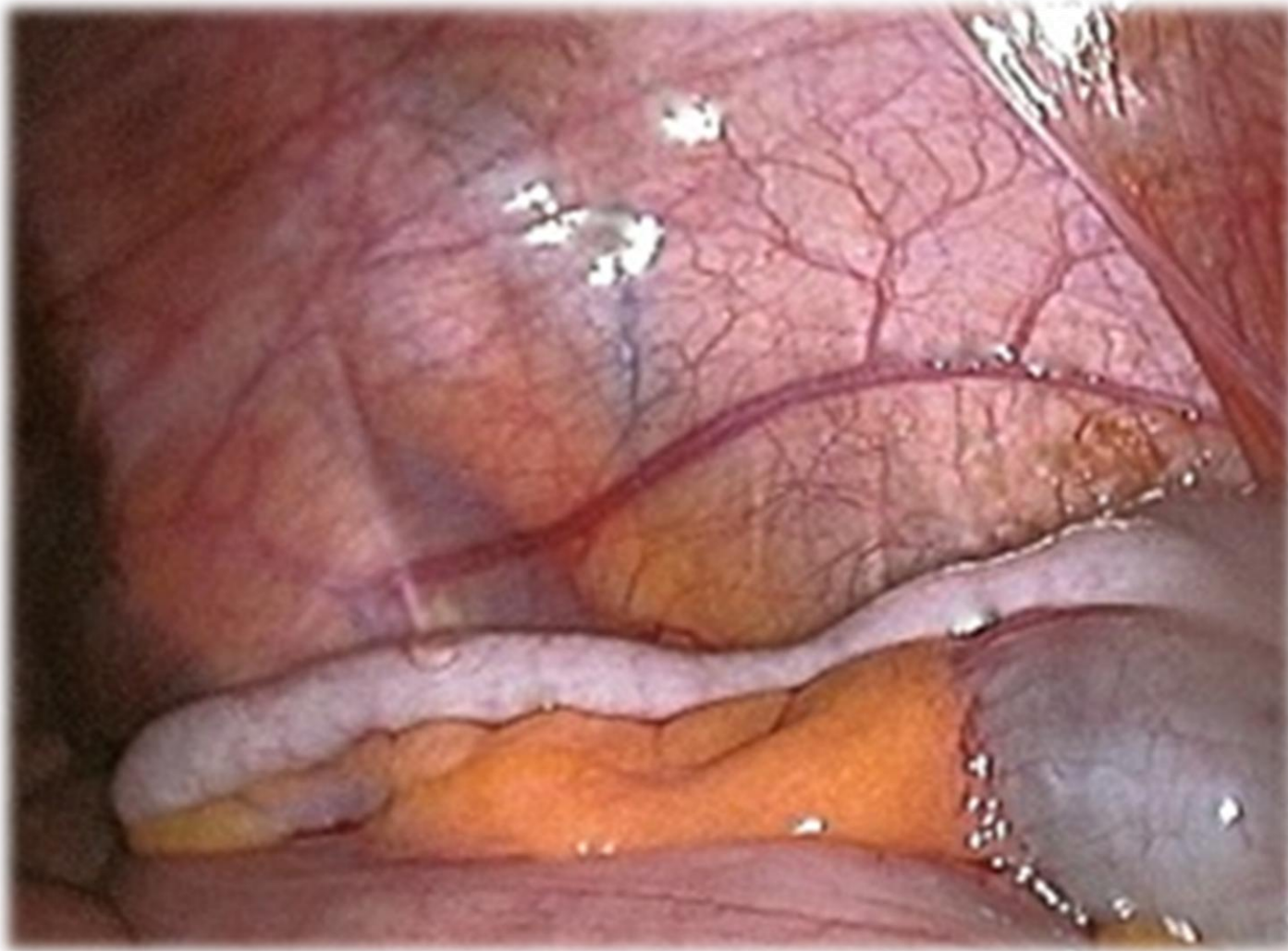
- A. L'atteinte est limitée à la muqueuse appendiculaire
- B. Il existe une ischémie de la paroi appendiculaire
- C. L'appendice est couvert de fausses membranes
- D. Il existe un épanchement péritonéal louche
- E. La lumière appendiculaire est pleine de pus

QCM: Aspects anatomopathologiques des appendicites aiguës

Au cours d'une appendicite catarrhale :

- A. L'atteinte est limitée à la muqueuse appendiculaire
- B. Il existe une ischémie de la paroi appendiculaire
- C. L'appendice est couvert de fausses membranes
- D. Il existe un épanchement péritonéal louche
- E. La lumière appendiculaire est pleine de pus

Appendice normal

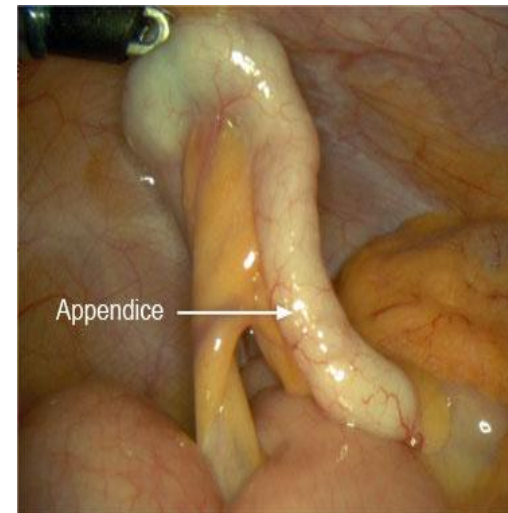
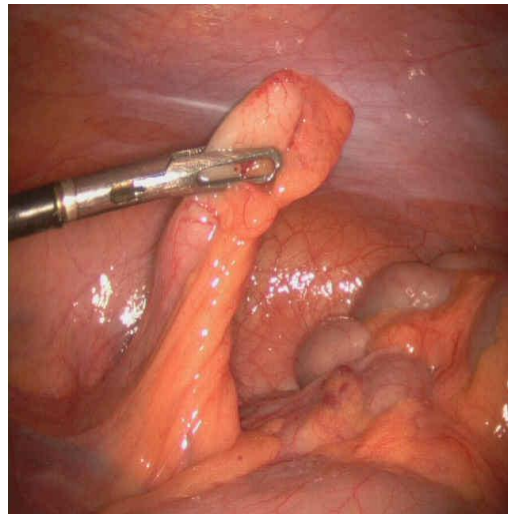
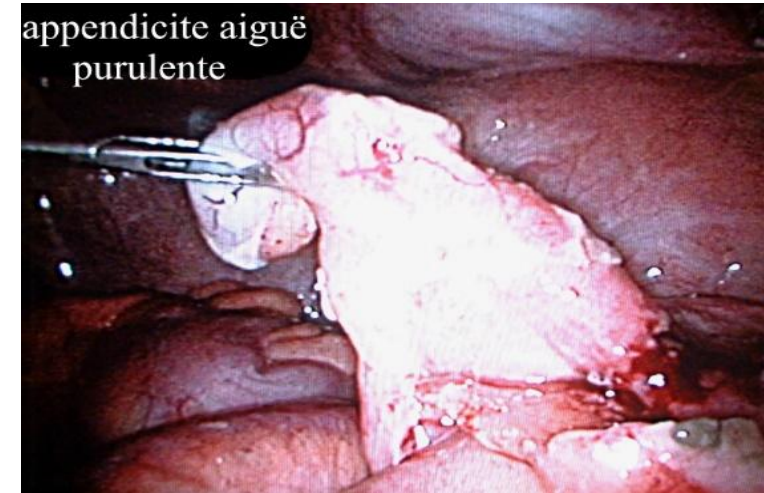
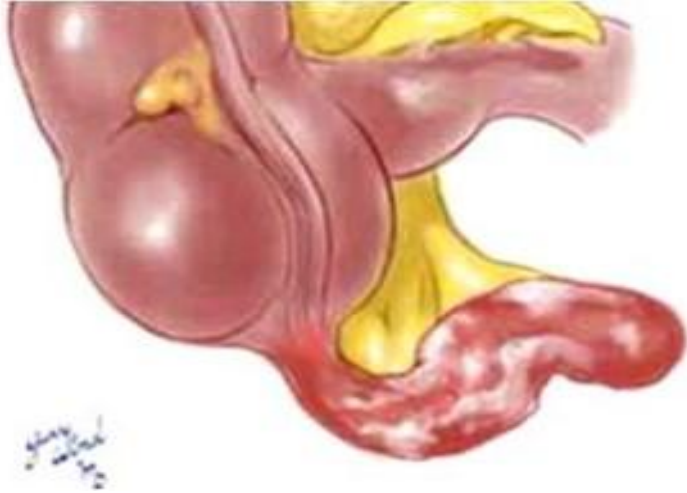


Anatomopathologie



- > **Catarrhale** : œdématisé, inflammatoire
- **Ulcérée ou Suppurée** : pus (lumière), fausse membrane (séreuse)
- > **Gangréneuse** : Verdâtre, destruction (pus fétide + gaz)
- > **Perforé**

Anatomopathologie



Anatomopathologie



Anatomopathologie



QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



L'appendicite aiguë:

- A. Est rare avant l'âge de 1 an
- B. Constitue l'urgence abdominale la plus fréquente
- C. Sa fréquence augmente après l'âge de 60 ans
- D. Touche les deux sexes
- E. Est caractérisée par la présence d'un parallélisme anatomoclinique

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

L'appendicite aiguë:

- A. Est rare avant l'âge de 1 an
- B. Constitue l'urgence abdominale la plus fréquente
- C. Sa fréquence augmente après l'âge de 60 ans
- D. Touche les deux sexes
- E. Est caractérisée par la présence d'un parallélisme anatomoclinique

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

La douleur d'une appendicite aiguë:

- A. Peut être à début péri ombilical
- B. Témoigne d'une forme compliquée lorsqu'elle est intense
- C. Donne une irradiation épigastrique
- D. Peut être associée à des nausées
- E. Est calmée par les mouvements

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

La douleur d'une appendicite aiguë:

- A. Peut être à début péri ombilical
- B. Témoigne d'une forme compliquée lorsqu'elle est intense
- C. Donne une irradiation épigastrique
- D. Peut être associée à des nausées
- E. Est calmée par les mouvements

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Concernant l'appendicite aiguë en position habituelle :

- A. Le début de la symptomatologie peut être épigastrique
- B. La défense de la fosse iliaque droite est un signe clinique constant
- C. La douleur est le seul signe constant
- D. L'absence d'hyperleucocytose élimine le diagnostic
- E. Une T° à 40°C est compatible avec le diagnostic d'appendicite aiguë non compliquée

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Concernant l'appendicite aiguë en position habituelle :

- A. Le début de la symptomatologie peut être épigastrique
- B. La défense de la fosse iliaque droite est un signe clinique constant
- C. La douleur est le seul signe constant
- D. L'absence d'hyperleucocytose élimine le diagnostic
- E. Une T° à 40°C est compatible avec le diagnostic d'appendicite aiguë non compliquée

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



L'examen physique d'une appendicite aiguë peut comporter :

- A. Une inspection à la recherche d'une cicatrice de Mac Burney, permettant d'écarter le diagnostic
- B. Une décompression de la fosse iliaque gauche
- C. Un toucher rectal, qui constitue un examen capital
- D. Une extension de la cuisse droite sur le bassin contre résistance
- E. Un toucher vaginal

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



L'examen physique d'une appendicite aiguë peut comporter :

- A. Une inspection à la recherche d'une cicatrice de Mac Burney, permettant d'écarter le diagnostic
- B. Une décompression de la fosse iliaque gauche
- C. Un toucher rectal, qui constitue un examen capital
- D. Une extension de la cuisse droite sur le bassin contre résistance
- E. Un toucher vaginal

Signes fonctionnels



-> Douleur abdominale aiguë spontanée +++

- ✓ **Siège** : FID, point de **Mac Burney** ; parfois de début épigastrique ou péri-ombilical puis FID
- ✓ **Début** progressive/brutal, continue, permanente
- ✓ **Types des douleurs** : picotement, torsion
- ✓ **Intensité** variable, souvent croissante
- ✓ Pas **d'irradiation**
- ✓ **S'accentue** lors des mouvements

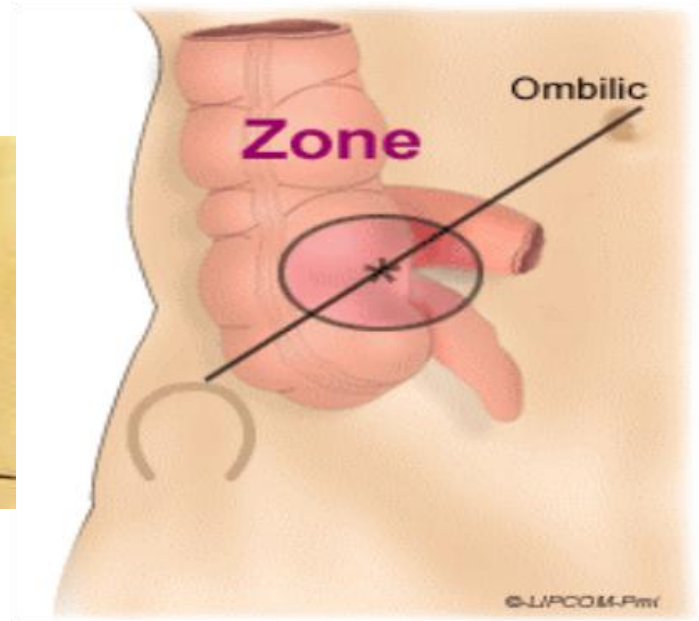
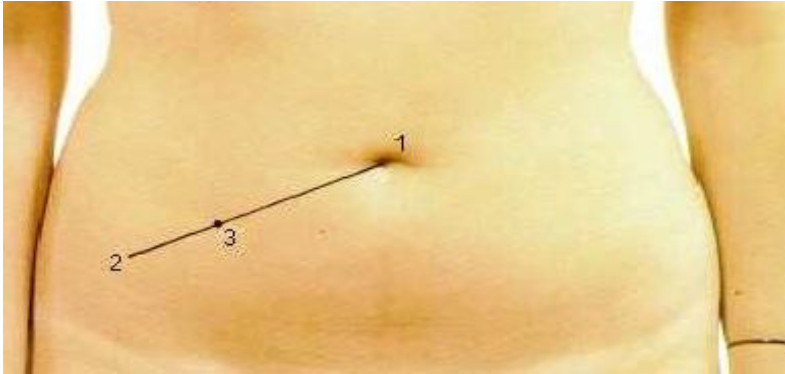
Signes fonctionnels



MAITRE SYMPTÔME

Ne manque presque jamais

Signes fonctionnels



QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



Le tableau d'une appendicite aiguë pelvienne peut comporter:

- A. Des douleurs hypogastriques
- B. Une occlusion fébrile
- C. Des brûlures mictionnelles
- D. Un ténesme rectal
- E. Un proctitis

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Le tableau d'une appendicite aiguë pelvienne peut comporter:

- A. Des douleurs hypogastriques
- B. Une occlusion fébrile
- C. Des brûlures mictionnelles
- D. Un ténesme rectal
- E. Un psoitis

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



Les signes cliniques d'une appendicite aiguë sous hépatique sont:

- A. Une défense de l'hypochondre droit
- B. Un psoitis
- C. Un signe de Rovsing
- D. Un ictère
- E. Une fièvre à 38°C

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Les signes cliniques d'une appendicite aiguë sous hépatique sont:

- A. Une défense de l'hypochondre droit
- B. Un psoitis
- C. Un signe de Rovsing
- D. Un ictère
- E. Une fièvre à 38°C

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



L'appendicite aiguë qui peut entraîner un tableau d'occlusion fébrile est une :

- A. Appendicite aiguë rétro caecale
- B. Appendicite aiguë latéro caecale interne
- C. Appendicite aiguë méso coélique
- D. Appendicite aiguë pelvienne
- E. Appendicite aiguë sous hépatique

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



L'appendicite aiguë qui peut entraîner un tableau d'occlusion fébrile est une :

- A. Appendicite aiguë rétro caecale
- B. Appendicite aiguë latéro caecale interne
- C. Appendicite aiguë méso coélique
- D. Appendicite aiguë pelvienne
- E. Appendicite aiguë sous hépatique

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Concernant l'appendicite aiguë chez un sujet âgé de 75 ans

- A. Peut se manifester par une occlusion fébrile
- B. Son évolution peut être lente et insidieuse
- C. Peut suggérer une tumeur du côlon droit
- D. La défense abdominale confirme le diagnostic
- E. Le tableau clinique est typique

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Concernant l'appendicite aiguë chez un sujet âgé de 75 ans

- A. Peut se manifester par une occlusion fébrile
- B. Son évolution peut être lente et insidieuse
- C. Peut suggérer une tumeur du côlon droit
- D. La défense abdominale confirme le diagnostic
- E. Le tableau clinique est typique

QCM: Diagnostic positif des appendicites aigues

En cas d'appendicite aiguë, l'échographie :

- A. Est indiquée en première intention chez les sujets âgés
- B. Est utile surtout pour éliminer les autres diagnostics
- C. Est indiquée pour les femmes obèses
- D. Peut montrer un appendice tuméfié
- E. Est plus performante que le scanner

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

En cas d'appendicite aiguë, l'échographie :

- A. Est indiquée en première intention chez les sujets âgés
- B. Est utile surtout pour éliminer les autres diagnostics
- C. Est indiquée pour les femmes obèses
- D. Peut montrer un appendice tuméfié
- E. Est plus performante que le scanner

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



En cas d'appendicite aiguë, l'échographie est l'examen de première intention dans les situations suivantes :

- A. En présence d'une défense de la fosse iliaque droite associée à une hyperleucocytose
- B. Chez la femme enceinte
- C. Chez les femmes obèses
- D. Chez les patients âgés de plus de 80 ans
- E. Devant un tableau clinique typique d'appendicite aiguë chez l'adulte jeune

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



En cas d'appendicite aiguë, l'échographie est l'examen de première intention dans les situations suivantes :

- A. En présence d'une défense de la fosse iliaque droite associée à une hyperleucocytose
- B. Chez la femme enceinte
- C. Chez les femmes obèses
- D. Chez les patients âgés de plus de 80 ans
- E. Devant un tableau clinique typique d'appendicite aiguë chez l'adulte jeune

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Les signes échographiques d'une appendicite aiguë sont :

- A. A. Diamètre appendiculaire ≥ 7 mm
- B. Épaississement pariétal ≥ 3 mm
- C. Épaississement du cæcum
- D. Infiltration de la graisse péri-appendiculaire
- E. Compression de l'appendice

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Les signes échographiques d'une appendicite aiguë sont :

- A. Diamètre appendiculaire ≥ 7 mm
- B. Épaississement pariétal ≥ 3 mm
- C. Épaississement du cæcum
- D. Infiltration de la graisse péri-appendiculaire
- E. Compression de l'appendice

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



En cas d'appendicite aiguë, la TDM abdominale :

- A. Est indiquée de façon systématique.
- B. Est l'examen radiologique le plus sensible
- C. Permet de poser le diagnostic différentiel avec une tumeur du colon droit.
- D. Permet un geste thérapeutique
- E. Est plus sensible que l'échographie chez les nourrissons

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



En cas d'appendicite aiguë, la TDM abdominale :

- A. Est indiquée de façon systématique.
- B. Est l'examen radiologique le plus sensible
- C. Permet de poser le diagnostic différentiel avec une tumeur du colon droit.
- D. Permet un geste thérapeutique
- E. Est plus sensible que l'échographie chez les nourrissons

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



En cas d'appendicite aiguë suspectée, la tomodensitométrie (TDM) abdominale est indiquée en première intention dans les situations suivantes :

- A. Chez un patient obèse
- B. Chez un patient âgé de plus de 40 ans
- C. Chez le nourrisson
- D. En cas de douleur intense
- E. En cas de tableau clinique atypique.

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



En cas d'appendicite aiguë suspectée, la tomodensitométrie (TDM) abdominale est indiquée en première intention dans les situations suivantes :

- A. Chez un patient obèse
- B. Chez un patient âgé de plus de 40 ans
- C. Chez le nourrisson
- D. En cas de douleur intense
- E. En cas de tableau clinique atypique.

Modification



Diagnostic positif de l'appendicite aiguë

- Le diagnostic de l'appendicite aiguë repose sur une approche multidimensionnelle, associant les données cliniques, biologiques et d'imagerie.
- L'imagerie occupe donc une place centrale dans la confirmation du diagnostic.

Modification



Diagnostic positif de l'appendicite aiguë : 1^{ère} intention

- Echographie abdominale
- Examen non concluant
 - Scanner abdomino-pelvien + PDC
 - IRM : femme enceinte

Modification



Diagnostic positif de l'appendicite aiguë : 1^{ère} intention

- Scanner Abdominal
 - Patient obèse
 - Patients âgés supérieur à 75 ans

Formes selon le siège

-> AA Retro-coecale



ATTENTION!

pyélonéphrite (ECBU)

Formes selon le siège

-> AA Pelvienne

- Douleur plus **bas** située (sus-pubienne ou hypogastrique)
- Signes **urinaires** irritatifs (BM, impériosités,..)
- Ténésme **rectal** ou symptômes **gynécologique**



Formes selon le siège

-> AA Sous-hépatique



ATTENTION!

Cholécystite aigue (échographie)

Formes selon le terrain

-> AA du vieillard

- Gravité liée au terrain
- 2 formes cliniques sont habituelles
 - ✓ Tableau d'une occlusion fébrile.
 - ✓ Toxique



Dg ≠ : Kc du colon droit !!

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Un abcès appendiculaire est suspecté devant:

- A. La notion de retard de consultation
- B. Une température à 37,8°C
- C. Une défense généralisée
- D. Une masse de la fosse iliaque droite
- E. Des signes urinaires

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Un abcès appendiculaire est suspecté devant:

- A. La notion de retard de consultation
- B. Une température à 37,8°C
- C. Une défense généralisée
- D. Une masse de la fosse iliaque droite
- E. Des signes urinaires

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



Devant une péritonite aiguë généralisée, on retiendra en faveur de son origine appendiculaire (non ectopique) :

- A. L'âge jeune
- B. L'absence de pneumopéritoine
- C. La notion de tabagisme
- D. Le début des signes au niveau de la fosse iliaque droite
- E. L'existence d'une défense de l'épigastre

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



Devant une péritonite aiguë généralisée, on retiendra en faveur de son origine appendiculaire (non ectopique) :

- A. L'âge jeune
- B. L'absence de pneumopéritoine
- C. La notion de tabagisme
- D. Le début des signes au niveau de la fosse iliaque droite
- E. L'existence d'une défense de l'épigastre

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

La péritonite appendiculaire :

- A. Est dite en 1 temps lorsque elle survient au 4^{ème} jour après sédation clinique
- B. Est dite en 1 temps lorsqu'elle survient d'emblée par perforation appendiculaire
- C. Est dite en 2 temps lorsqu'elle résulte d'une diffusion de l'infection sans intervalle libre
- D. Est dite en 3 temps par rupture d'un plastron appendiculaire
- E. Est dite en 3 temps par rupture d'un abcès appendiculaire

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

La péritonite appendiculaire :

- A. Est dite en 1 temps lorsque elle survient au 4^{ème} jour après sédation clinique
- B. Est dite en 1 temps lorsqu'elle survient d'emblée par perforation appendiculaire
- C. Est dite en 2 temps lorsqu'elle résulte d'une diffusion de l'infection sans intervalle libre
- D. Est dite en 3 temps par rupture d'un plastron appendiculaire
- E. Est dite en 3 temps par rupture d'un abcès appendiculaire

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Concernant le plastron appendiculaire :

- A. Est secondaire au moyen de défenses péritonéales
- B. Est suspecté devant une masse de la FID
- C. Est traité par voie chirurgicale
- D. Peut évoluer vers l'abcédation
- E. Peut évoluer vers une péritonite en un temps

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës

Concernant le plastron appendiculaire :

- A. Est secondaire au moyen de défenses péritonéales
- B. Est suspecté devant une masse de la FID
- C. Est traité par voie chirurgicale
- D. Peut évoluer vers l'abcédation
- E. Peut évoluer vers une péritonite en un temps

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



Le plastron appendiculaire :

- A. Constitue une évolution de l'appendicite aiguë vers une rétrocession initiale.
- B. Est constitué par une agglutination d'anses intestinales et de l'épiploon autour de l'appendice.
- C. Se traduit par un blindage pariétal.
- D. Nécessite une intervention chirurgicale en urgence.
- E. Se traduit par une masse profonde bien limitée

QCM: Diagnostic positif des appendicites aiguës



Le plastron appendiculaire :

- A. Constitue une évolution de l'appendicite aiguë vers une rétrocession initiale.
- B. Est constitué par une agglutination d'anses intestinales et de l'épiploon autour de l'appendice.
- C. Se traduit par un blindage pariétal.
- D. Nécessite une intervention chirurgicale en urgence.
- E. Se traduit par une masse profonde bien limitée

Formes compliquées



-> **Plastron appendiculaire**

- Evolution subaiguë AA : laisse le **temps** au péritoine de se **cloisonner** ➡ formation **d'adhérences** épiploïques et grêliques séparant la FID du reste de la cavité péritonéale.



Formes compliquées



-> Plastron appendiculaire

- **Tableau subaigu** : **atténuation** des signes initiaux + douleur à la FID **persistante**
- **Examen** : **blindage** la paroi, mal limité, mat à la percussion
- **Evolution** : la guérison ou abcédation.

Modification



- **Péritonite en 1 temps** : D'emblée par perforation appendiculaire ou par diffusion de l'infection sans temps libre ; elle survient au 4^{ème} - 5^{ème} jour d'évolution après une crise d'appendicite aiguë non opérée.
- **Péritonite en 2 temps** : Après une crise d'appendicite aiguë, sédation nette des signes durant 1 à 4 jours puis éclate brusquement une péritonite généralisée.
- **Péritonite en 3 temps** : Par rupture d'un abcès appendiculaire non pris en charge ou **d'un plastron abcédé.**

QCM: Principaux diagnostics différentiels



Concernant les formes topographiques de l'appendicite aigue:

- A. La forme méso-coélique mime le tableau d'une salpingite aigue
- B. La forme sous hépatique mime le tableau d'une cholécystite aigue
- C. La forme pelvienne mime le tableau d'une infection urinaire
- D. Donne un tableau de diverticulite sigmoïdienne en cas de situs inversus
- E. Donne un ébranlement lombaire douloureux dans sa forme LCI

QCM: Principaux diagnostics différentiels



Concernant les formes topographiques de l'appendicite aigue:

- A. La forme méso-coélique mime le tableau d'une salpingite aigue
- B. La forme sous hépatique mime le tableau d'une cholécystite aigue
- C. La forme pelvienne mime le tableau d'une infection urinaire
- D. Donne un tableau de diverticulite sigmoïdienne en cas de situs inversus
- E. Donne un ébranlement lombaire douloureux dans sa forme LCI

QCM: Principaux diagnostics différentiels



Parmi les propositions suivantes relatives au diagnostic des appendicites aiguës, citez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A. L'appendicite méso coélique peut donner un tableau similaire à une salpingite aiguë
- B. L'appendicite pelvienne peut être révélée par des signes urinaires
- C. L'appendicite retro-caecale peut donner un tableau similaire à une pyélonéphrite
- D. L'appendicite Sous-hépatique peut donner un tableau similaire à une angiocholite aiguë
- E. L'appendicite du sujet âgé peut donner un tableau similaire au tableau d'une tumeur du côlon droit.

QCM: Principaux diagnostics différentiels



Parmi les propositions suivantes relatives au diagnostic des appendicites aiguës, citez celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A. L'appendicite méso coélique peut donner un tableau similaire à une salpingite aiguë
- B. L'appendicite pelvienne peut être révélée par des signes urinaires
- C. L'appendicite retro-caecale peut donner un tableau similaire à une pyélonéphrite
- D. L'appendicite Sous-hépatique peut donner un tableau similaire à une angiocholite aiguë
- E. L'appendicite du sujet âgé peut donner un tableau similaire au tableau d'une tumeur du côlon droit.

QCM: Les principes de traitement de l'appendicite aiguë



En cas d'appendicite aiguë, le traitement médical par antibiothérapie :

- A. Est indiqué en première intention chez la femme enceinte.
- B. Est administré systématiquement en peropératoire, quel que soit le stade de l'appendicite
- C. N'est pas systématique en post-opératoire, sauf en cas d'appendicite compliquée.
- D. Associe habituellement une céphalosporine de 3^e génération et un imidazolé
- E. A une durée post-opératoire de 7 à 14 jours en cas d'abcès appendiculaire

QCM: Les principes de traitement de l'appendicite aigue



En cas d'appendicite aiguë, le traitement médical par antibiothérapie :

- A. Est indiqué en première intention chez la femme enceinte.
- B. Est administré systématiquement en peropératoire, quel que soit le stade de l'appendicite
- C. N'est pas systématique en post-opératoire, sauf en cas d'appendicite compliquée.
- D. Associe habituellement une céphalosporine de 3^e génération et un imidazolé
- E. A une durée post-opératoire de 7 à 14 jours en cas d'abcès appendiculaire

QCM: Les principes de traitement de l'appendicite aiguë



En cas d'appendicite aiguë, la coelioscopie est privilégiée en cas :

- A. Doute diagnostic
- B. Sujet âgé
- C. Patient obèse
- D. Abscess appendiculaire
- E. Péritonite appendiculaire

QCM: Les principes de traitement de l'appendicite aiguë



En cas d'appendicite aiguë, la coelioscopie est privilégiée en cas :

- A. Doute diagnostic
- B. Sujet âgé
- C. Patient obèse
- D. Abscess appendiculaire
- E. Péritonite appendiculaire

Modification



Diagnostics différentiels

- Le diagnostic différentiel varie en fonction :
 - ✓ Forme topographique
 - ✓ Terrain.

Cas clinique 1



Une patiente âgée de 32 ans consulte pour une douleur de la fosse iliaque droite. La patiente ne rapporte pas de signes urinaires.

A l'examen: La patiente est **fébrile :T= 38°C**, IMC= 24kg/m²,

Défense de la fosse iliaque droite

Examen gynécologique normal

→ Au bilan: **Leucocytes=12000 e/mm³, CRP=15 mg/l, BHCG négative.**

Cas clinique 1



Que proposez-vous ?

- A. Appendicectomie en urgence
- B. Antibiothérapie
- C. Coelioscopie exploratrice
- D. Echographie abdomino-pelvienne
- E. Scanner abdomino-pelvien

Cas clinique 1



Que proposez-vous ?

- A. Appendicectomie en urgence
- B. Antibiothérapie
- C. Coelioscopie exploratrice
- D. Echographie abdomino-pelvienne
- E. Scanner abdomino-pelvien

Cas clinique 1



A l'échographie abdomino-pelvienne: appendice non détectable , le reste de l'examen est sans anomalies.

Votre conduite à tenir est:

- A. Une coelioscopie exploratrice
- B. Une appendicectomie
- C. Une antibiothérapie
- D. Un scanner abdomino-pelvien
- E. Une surveillance

Cas clinique 1



A l'échographie abdomino-pelvienne: appendice non détectable , le reste de l'examen est sans anomalies.

Votre conduite à tenir est:

- A. Une coelioscopie exploratrice
- B. Une appendicectomie
- C. Une antibiothérapie
- D. Un scanner abdomino-pelvien
- E. Une surveillance

Cas clinique 1



A la TDM abdomino-pelvienne: appendice latéro-caecal interne de diamètre=6mm, pas d'autres anomalies, la patiente est toujours algique.

Quelle est votre conduite ?

- A. Une appendicectomie (Mac-Burney)
- B. Une surveillance
- C. Une antibiothérapie
- D. Une coelioscopie exploratrice
- E. Des anti-inflammatoires

Cas clinique 1



A la TDM abdomino-pelvienne: appendice latéro-caecal interne de diamètre=6mm, pas d'autres anomalies, la patiente est toujours algique.

Quelle est votre conduite ?

- A. Une appendicectomie (Mac-Burney)
- B. Une surveillance
- C. Une antibiothérapie
- D. Une coelioscopie exploratrice
- E. Des anti-inflammatoires

Cas clinique 2



Un patient âgé de 75 ans consulte pour une douleur de la fosse iliaque droite. Il rapporte la notion d'altération de l'état général avec méléna sans signes urinaires associés.

A l'examen : IMC=20 kg/m², défense de la fosse iliaque droite.

La biologie : leucocytes=16000, CRP=60.

Cas clinique 2



Que proposez-vous?

- A. Une appendicectomie
- B. Une coelioscopie exploratrice
- C. Une échographie abdominale
- D. Une antibiothérapie
- E. Un scanner abdominal

Cas clinique 2



Que proposez-vous?

- A. Une appendicectomie
- B. Une coelioscopie exploratrice
- C. Une échographie abdominale
- D. Une antibiothérapie
- E. Un scanner abdominal

Cas clinique 2



Le patient a été opéré en urgence, il a eu une appendicectomie par la voie de Mac Burney.

2 ans plus tard il consulte pour des douleurs abdominales, distension , arrêt des matières et des gaz avec vomissement.

La cicatrice opératoire est solide

ASP: NHA de type grêle

Cas clinique 2



Quel est votre diagnostic?

- A. Une éventration étranglée
- B. Une occlusion intestinale aigue sur bride
- C. Volvulus du colon pelvien
- D. Un abcès profond
- E. Une occlusion intestinale aigue néoplasique

Cas clinique 2



Quel est votre diagnostic?

- A. Une éventration étranglée
- B. Une occlusion intestinale aigue sur bride
- C. Volvulus du colon pelvien
- D. Un abcès profond
- E. Une occlusion intestinale aigue néoplasique

Cas clinique 3



Un patient âgé de 25 ans consulte pour une douleur de la fosse iliaque droite.

Le patient ne rapporte pas de signes urinaires.

A l'examen: IMC= 35kg/m², patient fébrile à 38°C, douleur à la palpation de la fosse iliaque droite.

Au bilan : leucocytes=14000, CRP=20mg/l.

Cas clinique 3



Que proposez-vous ?

- A. Une appendicectomie
- B. Un scanner abdominal
- C. Une échographie abdominale
- D. Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP)
- E. Une surveillance

Cas clinique 3



Que proposez-vous ?

- A. Une appendicectomie
- B. Un scanner abdominal
- C. Une échographie abdominale
- D. Une radiographie de l'abdomen sans préparation (ASP)
- E. Une surveillance

Cas clinique 4



Un patient âgé de 32 ans consulte pour une douleur de la fosse iliaque droite depuis 1 jour. Il ne rapporte pas de signes urinaires.

A l'examen abdominal : défense de la fosse iliaque droite.

Au bilan : leucocytes=16000, CRP=50mg/L

Cas clinique 4



Que proposez-vous?

- A. Une surveillance
- B. Une antibiothérapie
- C. Une appendicectomie
- D. Une coelioscopie exploratrice
- E. Une échographie abdominale

Cas clinique 4



Que proposez-vous?

- A. Une surveillance
- B. Une antibiothérapie
- C. Une appendicectomie
- D. Une coelioscopie exploratrice
- E. Une échographie abdominale

Cas clinique 4



L'échographie a confirmé le diagnostic d'appendicite aiguë. Le patient a bénéficié d'une appendicectomie par voie coelioscopique. Au 7^e jour post-opératoire, il présente une dysurie, une pollakiurie, un ralentissement du transit, une fièvre à 39 °C, une défense hypogastrique ainsi qu'une hyperleucocytose à 20 000 éléments/mm³.

Cas clinique 4



Quel est votre diagnostic?

- A. Abscès de la paroi
- B. Hémopéritoine
- C. Abscès du Douglas
- D. Péritonite généralisée
- E. Occlusion intestinale aiguë

Cas clinique 4



Quel est votre diagnostic?

- A. Abscès de la paroi
- B. Hémopéritoine
- C. Abscès du Douglas
- D. Péritonite généralisée
- E. Occlusion intestinale aiguë

Traitement



-> Indication :

-> AA non compliquée

- Appendicectomie en urgence.

-> Abscesses Appendiculaires

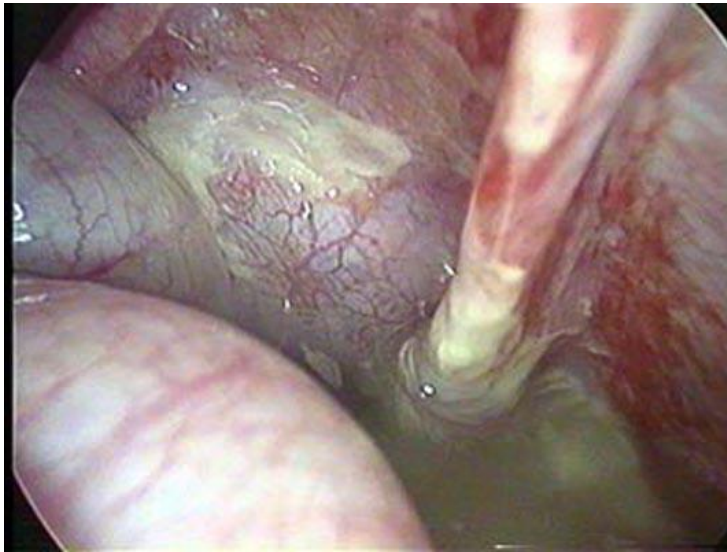
- 2 possibilités:
 - ✓ Drainage radiologique + ATB et appendicectomie secondaire
 - ✓ Chir d'emblée: drainage + appendicectomie

Traitement

-> **Indication :**

-> **Péritonite Appendiculaire**

- Voie médiane ou coelioscopie
- Toilette péritonéale, appendicectomie + drainage
- Réanimation hydroélectrolytique + antibiothérapie

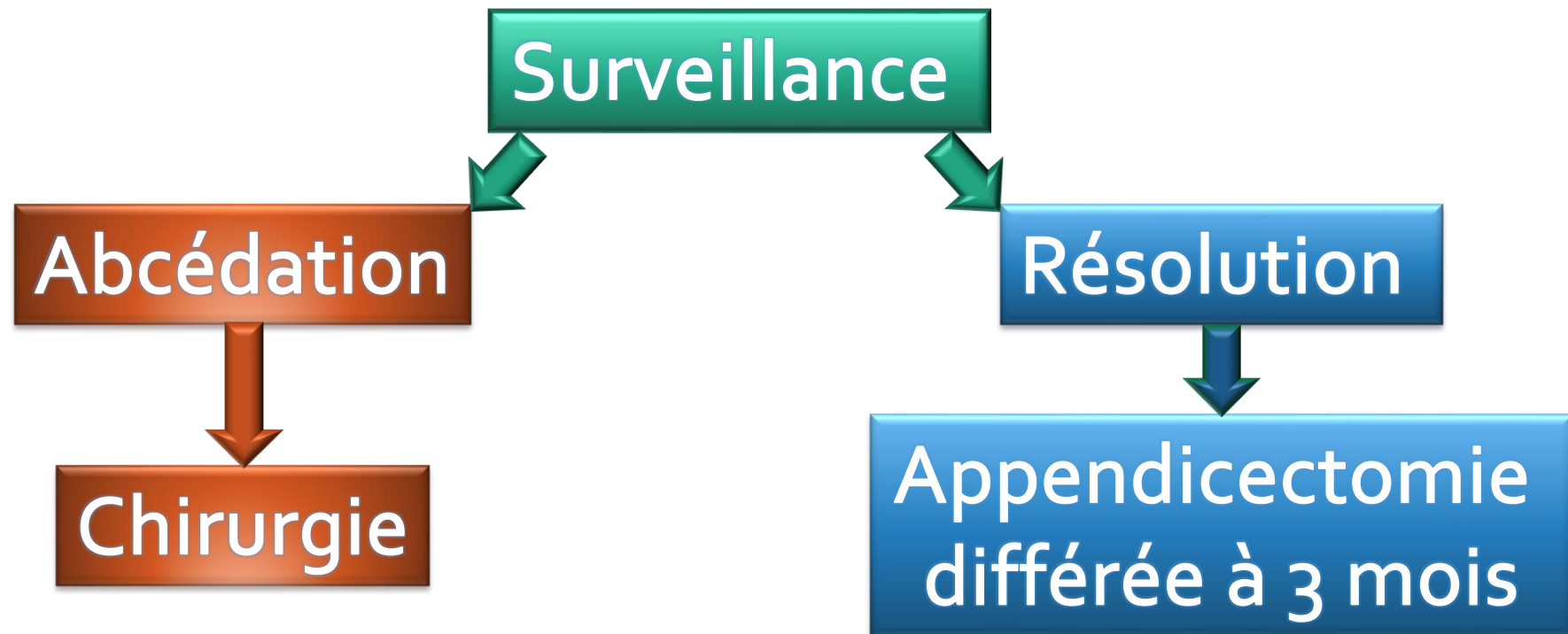


Traitement

-> **Indication :**

-> **Plastron : traitement médical**

- ATB curative contre les BGN et les anaérobies
- Antalgiques : médicaments et vessie de glace



Merci